

其体质、营养状况、生活条件差异,疾病临床表现、发展变化、转归是不尽相同的,由于西药化疗治疗方案相对固定,当出现严重药物不良反应、耐药等情况,调整治疗余地小,所以会导致部分病例治疗失败。而中医药治疗在辨证论治原则指导下,可以在最大限度内兼顾患者自身特质,在大原则下实现治疗的个体化、差异化。通过中西医结合抗痨治疗,可达到扶正祛邪,肺脾兼及,实现病情向愈之最终目的。

参考文献

[1] 王黎霞,成诗明,陈明亭,等. 2010 年全国第五次结核病流行病学

抽样调查报告[J]. 中国防痨杂志,2012,34(8):485-508.

[2] 张锡纯. 医学衷中参西录[M]. 石家庄:河北科学技术出版社,2002:17.

[3] 王群. 含结核灵片复治方案治疗 45 例耐多药肺结核疗效观察[J]. 重庆医学,2009,38(1):88-89.

[4] 李芳,左美容,贺卫国. 中西医结合治疗耐多药肺结核 60 例临床分析[J]. 中国医药指南,2013,11(1):12-13.

[5] 张晔敏,鹿振辉,郭晓燕,等. 益气滋阴、行瘀抗痨法联合化疗长疗程治疗耐多药肺结核的随机对照临床研究[J]. 上海中医药杂志,2012,46(9):44-46.

(本校校对:高旭超 收稿日期:2017-06-15)

医院合理用药理念下药物相互作用认知度调查与分析*

马利娟¹ 赵琦¹ 冯蕾心¹ 张明昊^{2△}

摘要:目的 了解医学与非医学专业人员对药物相互作用的认知度现状,为促进合理用药提供依据。方法 采用问卷调查方式,对选定医院 2016 年 10—12 月医务人员与门诊患者进行调查,共发放 300 份问卷,内容包括被调查者的基本情况、对药物相互作用了解程度、对药物相互作用知识的需求以及常见药物相互作用的实例调查。结果 共收回有效问卷 264 份,其中医学专业人员对药物相互作用了解的占 67.19%,有 76.56% 的人对药物相互作用知识有需求;非医学专业人员对药物相互作用了解的占 19.19%,有 84.30% 的人对药物相互作用知识有需求。在常见药物相互作用实例调查中,医学专业人员有一定了解,而非医学专业人员不了解者超过了半数。结论 民众对药物相互作用认知度不高,应重视并采取相应措施。

关键词:药物相互作用;认知度;调查

doi:10.3969/j.issn.1003-8914.2017.22.002 文章编号:1003-8914(2017)-22-3205-04

Investigation and Analysis of the Perception on Drug Interaction with the Idea of Rational Drug Use in Hospital

MA Lijuan¹ ZHAO Qi¹ FENG Leixin¹ ZHANG Minghao^{2△}

(1. The First School Of Clinical Medicine, Henan University of Traditional Chinese Medicine, Henan Province, Zhengzhou 450046, China;

2. School of Basic Medical Sciences, Henan University of Traditional Chinese Medicine, Henan Province, Zhengzhou 450046, China)

Abstract: Objective To investigate the perception of medical professionals and non-medical professionals on drug interaction in hospital, and to provide reference for improving rational use of drugs. **Methods** By questionnaire survey, medical workers and outpatients of selected hospital during October 2016 to December 2016 were investigated. 300 questionnaires involved basic situation of respondents, drug interaction cognition, drug interaction knowledge and case investigation. **Results** A total of 264 valid questionnaires were collected. The proportion of medical professionals who understood the drug interaction was 67.19%. 76.56% of peoples wanted to discern the drug-drug interaction. The proportion of non-medical professionals who understood the drug interaction was 19.19%. 84.30% of peoples wanted to discern the drug-drug interaction. In case investigation, medical professionals had some understanding about drug interaction, and more than half of non-medical professionals didn't understand drug interaction. **Conclusion** In our survey, people have low perception on drug interaction. Great importance should be attached to it and relevant measures should be conducted.

Key words: Drug interaction; Perception; Investigation

药物相互作用(drug interaction, DI)是指患者同

时或在一定时间内先后使用两种或两种以上药物后所产生的复合效应。这一效应可使药效加强或不良作用减轻,也可使药效减弱或出现不应有的毒副作用而危害用药者^[1]。现代医学发展使多药并用、多药同服成为治疗的首选,这在一定程度上埋下了药物相互作用的隐患。在医院合理用药前提下,药物相互作用具有隐蔽性、复杂性,容易被医生、患者所忽略^[2],如服用

* 基金项目:地方高校国家级大学生创新创业训练计划项目(No. 201610471010);河南中医药大学大学生创新学习项目(No. CXXM [2016] 0010)

作者单位:1. 河南中医药大学第一临床医学院(郑州 450046);2. 河南中医药大学基础医学院(郑州 450046)

△通讯作者

避孕药的同时服用了利福平等抗菌药或镇静药,导致避孕失效而意外怀孕;服用抗抑郁药的同时服用了抗过敏药,导致抑郁症状得不到控制^[9]。因此研究合理用药前提下药物的相互作用,可以杜绝医院内药物滥用,对评价合理用药更具指导意义。为了解医务人员和患者对药物相互作用知识、态度和行为的认知状况,分析其影响因素并提出对策,笔者对河南中医药大学第一附属医院、郑州市中医院等医务人员与患者进行了一次药物相互作用认知度调查,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 随机抽取 2016 年 10—12 月医院医务人员(医学专业人员)及来医院就医的门诊患者(非医学专业人员)作为被调查者,对他们进行了问卷调查。

1.2 方法 针对社会比较关注的常用药物相互作用情况,自行设计了问卷调查表,调查内容设计被调查人员的基本情况、医学背景、用药种数、对药物相互作用知识的了解程度以及合理用药需求。问卷最后还分别列出了 5 组不应同时使用的化学药、中草药与食物,请被调查者自行选择哪 2 种不能同时使用。所有被调查者在无顾虑的情况下如实填写了调查问卷。

2 结果

2.1 被调查者基本情况 本次调查共发放调查问卷 300 份,收回的有效问卷 264 份,有效率为 88.00%。被调查者基本情况统计见表 1。

表 1 被调查者基本情况统计结果 (例,%)

特征	项目	样本数	构成比
性别	男	167	55.67
	女	133	44.33
文化程度	博士	5	1.67
	硕士	17	5.67
	大学	199	66.33
	高中	56	18.67
	初中及以下	23	7.67
年龄分布	18 岁以下	4	1.33
	19~28 岁(含)	64	21.33
	29~38 岁(含)	54	18.00
	39~48 岁(含)	46	15.33
	49~58 岁(含)	49	16.33
	59 岁以上	83	27.67
医学背景	医学专业人员	128	42.67
	非医学专业人员	172	57.33

注:服用 6~10 种药物的有 19 人(6.33%),服用 10 种以上药物的有 6 人(2.00%)

2.2 对药物相互作用了解程度 医学专业人员对“您对药物相互作用的了解吗?”一项回答“没听说过”(0 人)及“少许了解”(42 人)的占总调查人数的 32.81%;回答“比较了解”(61 人)的占总调查人数的 47.66%;回答“非常了解”(25 人)的占总调查人数的 19.53%。非医学专业人员对“您对药物相互作用的了解程度”一项回答“没听说过”(18 人)及“少许了解”(121 人)的占总调查人数的 80.81%;回答“比较了解”(22 人)的占总调查人数的 12.79%;回答“非常了解”(11 人)的占总调查人数的 6.40%。当问到“您了解哪方面的药物相互作用?”时,医学专业人员回答了解“化学药之间相互作用”的有 59 人(46.09%);回答“了解中药与中药之间相互作用”的有 71 人(55.47%);回答“了解化学药与中药相互作用”的有 13 人(10.16%)(以上选项中有 15 人有≥2 项的重复选择)。非医学专业人员回答了解“化学药之间相互作用”的有 45 人(26.16%);回答“了解中药与中药之间相互作用”的有 53 人(30.81%);回答“了解化学药与中药相互作用”的有 5 人(2.91%);回答“哪方面都不了解”的有 69 人(40.12%)。

2.3 对药物相互作用知识的需求 医学专业人员对“您是否需要了解药物相互作用”一项回答“非常需要”(98 人)占总调查人数的 76.56%;回答“需要时再说”的有 21 人(16.41%);回答“不需要”的有 9 人(7.03%)。非医学专业人员回答“非常需要”的有 145 人(84.30%),回答“需要时再说”的有 23 人(13.37%),回答“不需要”的有 4 人(2.33%)。

2.4 对常见药物相互作用实例调查

2.4.1 对 4 组可发生相互作用的化学药调查 调查中,非医学专业人员对 4 组化学药间相互作用“都不了解”的有 77 人(44.77%)。见表 2。

表 2 对 4 组可发生相互作用的化学药调查

药品名称	统计结果 (例,%)			
	医学专业人员		非医学专业人员	
	了解人数	构成比	了解人数	构成比
阿莫西林 ^[10] 与阿奇霉素	108	84.38	43	25.00
吉非贝齐 ^[11] 与辛伐他丁	87	67.97	17	9.88
西咪替丁 ^[12] 与二甲双胍	98	76.56	25	14.53
米贝拉地尔 ^[13] 与美托洛尔	63	49.22	10	5.81

2.4.2 对 5 组可发生相互作用的中药调查 调查中,非医学专业人员对 5 组中药间相互作用“都不了解”的有 88 人(51.16%)。见表 3。

表 3 对 5 组可发生相互作用的中药

调查统计结果 (例,%)

药品名称	医学专业人员		非医学专业人员	
	了解人数	构成比	了解人数	构成比
附子与瓜蒌	88	68.75	11	6.40
白芍与藜芦	85	66.41	10	5.81
甘草与海藻	97	75.78	20	11.63
止咳橘红丸与附子理中丸	79	61.72	18	10.47
六味地黄丸与牛黄解毒丸	117	91.41	25	14.53

2.4.3 对 5 组可发生相互作用的化学药与中药联合应用调查 调查中,非医学专业人员对 5 组化学药与中药联合应用的相互作用“都不了解”的有 123 人(71.51%)。见表 4。

表 4 对 5 组可发生相互作用的化学药与

中药联合应用调查统计结果 (例,%)

药品名称	医学专业人员		非医学专业人员	
	了解人数	构成比	了解人数	构成比
红霉素 ^[8] 与含重金属离子中药	51	39.84	6	3.49
复方铝酸铋片 ^[9] 与丹参	61	47.66	8	4.65
维生素 C ^[10] 与黄芩	48	37.50	6	3.49
阿司匹林 ^[11] 与甘草	57	44.53	10	5.81
复方利血平氨苯蝶啶片与麻黄 ^[12]	78	60.94	19	11.05

2.4.4 对 5 组可发生相互作用的药物与食物调查 传统中医理论认为药物与食物之间存在禁忌,这也是药物之间相互作用的一种表现形式。在此次调查中,非医学专业人员对 5 组药物与食物的相互作用“都不了解”的有 55 人(31.98%),选择“比较了解”的多是长期服用中药的慢性病患者,这可能是目前化学药物使用较多导致的。见表 5。

表 5 对 5 组可发生相互作用的药物与食物

调查统计结果 (例,%)

药品名称	食物名称	医学专业人员		非医学专业人员	
		了解人数	构成比	了解人数	构成比
丹参	醋	92	71.88	12	6.98
桔梗	猪肉	91	71.09	13	7.56
土茯苓	茶水	95	74.22	18	10.47
薄荷	螃蟹	112	87.50	39	22.67
西洋参	萝卜	105	82.03	35	20.35

2.5 对合理用药咨询需求的调查结果 对开设合理用药咨询服务这一项目医学专业人员全部选择了“非常必要”;非医学专业人员除 5 人认为“可有可无”外,其他大部分人都认为“非常必要”(167,97.09%)。

3 讨论

欧洲医药评价署/专利药品委员会(EMEA/CPMP)于 1998 年 6 月发布的《药物相互作用研究指导原则》中把“合并用药、饮食因素或社会习惯等引起的药物药代动力学和/或药效学改变”定义为药物相互作用,这就使其不仅包括药物与药物之间的相互作用,还包括药物与烟、酒、食物之间的作用。根据药物相互作用发生原理,可将其分为药物代谢动力学相互作用和药效学相互作用。药理学相互作用主要包括吸收、分布、代谢和排泄等因素的影响而引起的药物相互作用;药效学相互作用主要包括无关、协同、相加、拮抗等作用。美国一项调查显示,在住院患者中,每日使用 1~5 种药物,潜在药物相互作用发生率为 12.1%;使用 11~15 种药物,潜在药物相互作用发生率为 44.8%,每年因药物相互作用而致死的百分率已位居住院患者致死原因中的 4~6 位,可见此问题越来越引起了医学工作者重视。我国的药物相互作用研究尚处于起步阶段,从中国期刊全文数据库(CNKI)中检索到的研究资料以基层医院临床人员中西药配伍使用经验总结或研究综述为主,缺乏实质性调研分析与系统研究,亦没有完整的药物相互作用理论体系。

本文对医学合理用药前提下药物相互作用的民众认知度进行了调查,以期更好地认识药物相互作用,促进合理用药。调查结果显示,医学专业人士在对药物相互作用知识掌握方面存在一定的不足,认为自己非常了解的只占 19.53%。对于医学专业人士来说,了解化学药、中药及药物与食物的相互作用是很有必要的,否则极易造成处方失误,给患者带来身体损害。非医学专业人士对药物相互作用的了解和认知程度较为低下,对调查表中所列化学药、中药及药物与食物的相互作用了解者甚少,仅有 6.40% 的人表示非常了解。大多数非医学专业人士认为需要了解药物相互作用,但也有 2.33% 的人表示不需要。

本次调查结果显示,民众对药物相互作用的认知存在一定程度的不足,对化学药物、中药及药物与食物相互作用的了解较少,这与药品不良反应的检测工作比较明显存在重视度不足,因此应加大对合理用药及药物相互作用的宣传力度,并对药品相互作用进行深入研究,让更多民众认识药物相互作用的严重性,了解药物相互作用知识,医疗单位也要加强对药物相互作用知识培训,及时给患者提供明确的用药指导,这样就可以对可能产生的有害后果进行预警与干预。

参考文献

- [1] 刘治军,傅得兴,孙春华,等. 体内药物相互作用研究进展[J]. 药物不良反应杂志,2006,8(1):33-38.

- [2] 刘萍,陈玉文,何新荣,等. 我院就医患者对药物相互作用的认知度调查与分析 [J]. 中国药房,2011,22(21):2011-2013.
- [3] 刘治军,傅得兴,孙春华,等. 抗抑郁药物相关的药物相互作用 [J]. 中国药理学杂志,2007,42(6):409-414.
- [4] 于秋影,石磊,孟丽霞,等. 我院处方评价及结果分析 [J]. 中国医院用药评价与分析,2010,10(3):277-278.
- [5] Graham DJ, Staffa JA, Shatin D, et al. Incidence of hospitalized rhabdomyolysis in patients treated with lipid-lowering drugs [J]. JAMA, 2004, 292(21):2585.
- [6] 赵建来. 降血糖药不可滥用 [J]. 中国社区医师,2008,24(10):33.
- [7] Mullins ME, Horowitz BZ, Linden DH, et al. Life-threatening interaction of mibefradil and beta-blockers with dihydropyridine calcium channel blockers [J]. Jama, 1998, 280(2):157-158.
- [8] 李有才. 常用中西药物配伍禁忌 [J]. 中国社区医师,2004,20(11):26-27.
- [9] 周顺,滕树忠. 中西药联用对临床疗效的影响 [J]. 中国现代医生,2008,46(8):100-101.
- [10] 陶维良,常小红,李静. 呼吸系统药物相互作用评价 [J]. 中国医院用药评价与分析,2008,8(3):174-175.
- (本文校对:李光 收稿日期:2017-07-14)

血府逐瘀汤加减治疗瘀血痹阻型冠心病的临床研究

张国芳¹ 袁清茹¹ 谢豪杰²

摘要:目的 观察血府逐瘀汤加减治疗瘀血痹阻型冠心病的临床疗效。方法 将冠心病患者 200 例随机分成治疗组和对照组各 100 例。对照组给予西医常规治疗,治疗组在西医常规治疗的基础上给予血府逐瘀汤加减,10 天为一个疗程,治疗 3 个疗程后观察两组患者的临床症状、证候积分、心电图的变化情况。结果 治疗组在临床症状改善、心电图变化以及中医证候积分变化方面的疗效均优于对照组 ($P < 0.05$)。结论 血府逐瘀汤加减改善瘀血痹阻型冠心病患者的心绞痛症状和心电图疗效优于单纯西药治疗。

关键词: 血府逐瘀汤加减; 瘀血痹阻型冠心病; 中医药疗法

doi:10.3969/j.issn.1003-8914.2017.22.003 文章编号:1003-8914(2017)-22-3208-02

Clinical Study on Modified Xuefu Zhuyu Decoction in the Treatment of Coronary Heart Disease with Blood Stasis Syndrome

ZHANG Guofang¹ YUAN Qingru¹ XIE Haojie²

(1. Heart Center, Zhengzhou Ninth People's Hospital, Henan Province, Zhengzhou 450053, China;

2. Department of Endocrinology and Metabolism, Zhengzhou Ninth People's Hospital, Henan Province, Zhengzhou 450053, China)

Abstract: **Objective** To observe the curative effect of Xuefu Zhuyu decoction in the treatment of coronary heart disease with blood stasis syndrome. **Methods** 200 patients with coronary heart disease were randomly divided into treatment group and control group, with 100 cases in each group. The control group was given routine treatment of Western medicine. The treatment group was treated with Xuefu Zhuyu decoction on the basis of routine treatment of Western medicine. The course of treatment was given for 10 days. After treatment for 3 courses, the clinical symptoms, syndrome scores, electrocardiogram changes were observed. **Results** The curative effect of the treatment group was better than that of the control group ($P < 0.05$) in the improvement of clinical symptoms, changes of ECG and changes of TCM syndrome scores. **Conclusion** Modified Xuefu Zhuyu decoction can improve the symptoms of angina pectoris and electrocardiogram in patients with coronary heart disease.

Key words: Xuefu Zhuyu decoction; Coronary heart disease with blood stasis type; Therapy of TCM

冠心病是冠状动脉血管发生动脉粥样硬化病变而引起血管腔狭窄或阻塞,造成心肌缺血、缺氧或坏死而导致的心脏病,往往病情反复,迁延难愈,严重影响患者的生存质量,给患者带来极大的精神及经济负担,目前西医尚无根治方法,笔者在临床中运用血府逐瘀汤

加减联合西医常规治疗瘀血痹阻型冠心病,在改善患者的临床症状和心电图以及中医证候积分方面疗效显著,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 所有病例均为本院 2016 年 11 月—2017 年 5 月门诊或住院患者 200 例,均符合诊断标准,证型为瘀血痹阻型。200 例病例随机分为治疗组和对照组各 100 例。治疗组:男 56 例,女 44 例,年龄

作者单位:1. 河南省郑州市第九人民医院心脏中心(郑州 450053);
2. 河南省郑州市第九人民医院内分泌代谢科(郑州 450053)